

Fecha Última Actualización: 03-10-2023 8:34:22

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Adriana María Cintolesi Rawlins
Edad : 68a 3m 2d
Dirección : Canal Montino 2596

Rut : 6.064.463-2
Fecha Nacto: 01/07/1955
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A618254
Sexo : Femenino
Teléfono : 944750420

N° Epicrisis
371457

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Traumatología Y Ortopedia
Unidad de Egreso : Traumatología Y Ortopedia

Fecha Ingreso : 28/09/2023 07:21
Fecha Egreso : 03/10/2023 08:10

Días Estadía: 5

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Cirugía de revisión de prótesis total de rodilla izquierda

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Endoprotesis Total De Rodilla, (Cualquier Tecnica) - 28/09/2023 00:00 - Francisco Javier Figueroa Berrios

Epidemiología

Resumen Clínico

Médicos: DM NIR, HTA, Artrosis, Osteoporosis, síndrome extrapiramidal
Medicamentos: Hidralazina; Amlodipino; isosorbide; losartan; zopiclona; alneondronato; EcalD; metformina; sertralina.
Qx: Prótesis rodilla bilateral; apendicectomía.
Alergias: no refiere.
Hábitos: drogas (-), alcohol (-), tabaco (-)

Paciente ingresa por unidad prequirúrgica, con diagnóstico de aflojamiento aséptico de prótesis total de rodilla izq, para cirugía de revisión de prótesis rodilla izquierda. Se realiza procedimiento sin incidentes. Radiografías de control post op satisfactorias. Cultivos intrapabellón negativos, ecodoppler negativo para TVP, exámenes de control ok.
Tras buena evolución postoperatoria se decide alta hospitalaria, continuar con kinesioterapia ambulatoria y control ambulatorio precoz.

Diagnóstico de Egreso

Gonartrosis - Aflojamiento aséptico prótesis total de rodilla izquierda

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Evolución satisfactoria, hemodinamia estable, afebril, adecuado manejo del dolor, parches limpios y secos, examen neurovascular distal conservado, sin signos de trombosis venosa profunda, piel sin signos de infección.

Plan Post Alta

Reposo relativo, Mantener extremidad inferior izquierda en alto
Marcha con 2 bastones o burrito con carga a tolerancia
Aplicar frío local por 15-20 minutos varias veces al día protegiendo la piel
Cuidar parches, no mojar, manipular ni retirar
Paracetamol 500mg 2 comprimidos cada 8 horas por 14 días
Ketoprofeno 100mg 1 comprimido cada 8 horas por 7 días
Tramadol gotas (100mg/10ml) tomar 8-10 gotas solo en caso de dolor, máximo cada 8 horas
Cefadroxilo 500mg 1 comprimido cada 12 horas por 14 días
Enoxaparina 40mg administrar 1 vez al día vía subcutánea por 30 días

Fecha Epicrisis : 03/10/2023 08:34

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 03-10-2023 8:34:22

Página 2 de 2

Omeprazol 20mg, 1 comprimido al día por 14 días

Pregabalina 75 mg, 1 comprimido cada 12 horas por 30 días

Sulfato ferroso 200mg, 1 comprimido cada 8 horas por 30 días

Control medico con Dr.Francisco Figueroa en 1 semana en CDT Pasillo 4 (pedir hora con este documento, sobrecupo autorizado)

Acudir a pasillo 6 CDT con orden de kinesiología para tramitar inicio de kinesiología ambulatoria a la brevedad

Si presenta problemas con el parche acudir al CDT Pasillo 2

En caso de presentar Fiebre, dolor intratable o problemas con la herida acudir a Urgencias SOS

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposodico, Diabetico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

María Loreto Figueroa Berríos

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)